

面對可能到來的“呼吸衰竭”，醫療團隊會詢問大家的醫療意見，包括

1. 若不“插管”，氣就會不夠人就會死亡時，是否要“插管”？

- 什麼是“插管”？

“插管”是指從嘴巴放一根管子經過喉嚨抵達胸腔氣管，以連接呼吸器以協助病人呼吸。

“插管”不是“氣切”。

- 插管過程中會否不舒服或有危險？

插管時，會使用鎮靜麻醉藥物，過程中病人會睡着，之後也會維持睡着狀態一段時間。

需要插管的病人本就是即將“呼吸衰竭”、高度不穩定的病人，在插管過程中病況可能惡化，進展到心跳呼吸停止。另外，鬆動的牙齒偶爾會斷裂或掉落。

- 插管後會否不舒服？

有做過快篩就知道，有異物在我們的呼吸道就是會不舒服。插管是相當侵入性的治療，病人會不舒服。即使我們會使用鎮靜止痛藥物緩解他的不舒服，在不舒服昏昏沉沉的狀況下，病人仍然可能用手去拉扯管路造成生命危險，所以插管病人的雙手一定會約束——用安全帶綁在床上。另外，嘴巴喉嚨被呼吸管道占據，病人會無法經口進食和說話。會需要另外置放鼻胃管（從鼻子經過食道到胃）提供營養。

- 插管後的病況會如何進展？後續會需要“氣切”嗎？

發展因人而異：

1. 好的話，等肺部恢復，直接拔管脫離呼吸器；

2. 壞的話，肺部恢復不好（例如老人家、心肺肝腎等器官功能差==、癌症...），無法直接拔管脫離呼吸器。這時要考慮是否做“氣切”。“氣切”是到開刀房進行手術，在頸項正面開洞，放氣切管以連接呼吸器協助呼吸。氣切後是否一輩子依賴呼吸器，需要看病況恢復得如何。

3. 最糟糕的話，肺部持續惡化，病人死亡。

2. 若病況惡化造成心跳呼吸停止，是否要壓胸電擊急救？

每個人每個家庭對生命的想法不同，沒有哪種決定一定是對的或錯的。家人們要基於過去與病人本人相處的點點滴滴，共同為他做一個最適合的決定。

不管有沒有插管，大病一場，體力一定大幅下降，可能長期臥床；腦力也一定大幅下降，反應變慢。不管有沒有插管，其它疾病如心肺肝腎等器官衰竭、癌症還是會繼續進展惡化。

不插管、不急救、不施行心肺復蘇 DNR，不代表我們放棄病人。我們依然會給予病人各種治療，包括氧氣、抗生素、氣管擴張劑、化痰藥、抗發炎藥物、點滴、胸腔照護等，以緩解病人的病況及不適。在為家人做生命重要決定時，除了愛，我們還需要勇氣。